5.2.1. 수술 시 환자안전보장

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	수술실위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 5.2 수술 중 환자안전보장 JCI Standard 7th Edition: IPSG.4, 4.1, ASC.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

제1조 (목적)

1. 수술 시 환자와 관련하여 발생할 수 있는 문제를 예방하여 환자안전을 보장하기 위함이다

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 수술 전/후 환자의 피부상태 확인
   1) 수술 전 환자의 피부상태 확인
      (1) 수술 전 환자의 피부상태를 확인한다.
      (2) 피부상태를 사정하여 특이사항 없음 또는 피부상태 이상이 있을 때에는 부위, 크기를 수술간호기록에 기록한다.
      (3) 수술 후 체위에 따른 피부 손상 여부를 확인하기 위해 수술체위를 수술간호기록에 기록한다.
      (4) 전기소작기 접지 부위를 수술간호기록에 기록한다.
   2) 수술 후 환자의 피부상태 확인
      (1) 수술 동안 장기간 부동자세 유지, 수술고정기구, 전기소작기 등의 위험요인으로 인해 발생할 수 있는 피부손상을 확인하기 위해 수술 후 환자의 피부상태를 사정한다.
      (2) 피부상태를 사정하여 특이사항 없음 또는 피부상태에 이상이 있을 때에는 부위와 크기를 기록하며 의사에게 알린다.
      (3) 피부상태 이상에 대하여 보고 받은 의사는 피부상태를 확인한 후, 필요에 따라 처치를 시행한다.
      (4) 필요 시 환자 인계 부서에 구두인계한다.
      (5) 그 외, 수술체위, 광원사용 장비에 의한 관리 등 세부사항은 [부록1. 수술환자 피부관리 지침]을 따른다.

2. 수술계수 관리
   1) 계수 물품: 수술 시 사용된 모든 물품을 확인하며, 아래의 품목을 포함한다.
      (1) Tape, Gauze
      (2) 모든 Sharps류
      (3) 수술기구

(4) 기타 체내에 들어갈 수 있는 물품

2) 계수 시점 및 시행자

(1) 1차 Count

① 수술 시작 전에 소독간호사 및 순회간호사가 동시에(함께) 시행한다.

② 수술 중 물품을 추가할 때도 동일한 방법으로 시행한다.

(2) 2차 Count

① 체강을 닫기 직전에 소독간호사 및 순회간호사 동시에(함께) 시행한다.

② 체강을 열지 않은 수술은 피부봉합 직전 2차 Count에서 종료한다.

(3) 3차 Count

① 피부를 봉합하기 직전에 시행한다. (체강을 여는 경우 반드시 시행한다.)

(4) Count 완료 후 인수인계한다.

3) 계수 방법

(1) 모든 Count 과정은 두 사람이 함께 소리를 내어 계수하여야 하며, 계수확인 뿐 아니라 물품의 원형이 그대로 유지되어 있는지도 확인해야 한다.

(2) 린넨이나 쓰레기통은 모든 Count가 완전하게 종료될 때까지 수술방 밖으로 옮기지 않는다.

(3) Gauze, Tape, Needle, Sharps, 기구 등에 대한 세부 Count 지침은 [부록2. 수술계수(count) 관리 지침]을 따른다.

4) 기록 대상: Gauze, Tape, Sharps, 기구, 기타 체내에 들어갈 수 있는 모든 물품 등

5) 수술 Count 불일치 시 대처 절차

(1) 즉시 집도의에게 보고한다.

(2) 재 Count한다.

(3) 순회간호사는 침대 밑, 수납장 주변 등 방을 철저히 확인한다.

(4) 소독간호사는 Mayo stand 주변, 기구 Tray, Drape 주변 등을 철저히 확인한다.

(5) 수술 중 사용된 이동형 장비(X-ray 장비, 복강경장비 등)의 바퀴 등에 끼어 거즈류가 이동되지 않았는지 재확인한다.

(6) 집도의는 수술부위를 다시 확인한다.

(7) 모든 노력을 기울인 후에도 찾지 못한 경우에는 환자가 수술실을 벗어나기 전에 X-ray를 전후(Anterior-Posterior, AP)와 측면(Lateral, Lat) 방향을 찍은 다음 집도의가 직접 그 결과를 판독한 후 환자 몸에 남아 있는지 여부를 확인하여 결과에 따라 조치하도록 한다.

(8) 최종 수술참여자가 Count 불일치 보고서를 작성한다.

(9) 환자안전보고서를 작성한다.

6) 응급수술 시 Count

(1) 가능한 순회간호사 및 소독간호사가 동시에(함께) Count를 시행한다.

(2) 필요 시 타 인력에 도움을 요청하여 반드시 Double Count를 수행한다

(3) 불가피한 사유로 Count를 수행하지 못한 경우, ‘Count work sheet’와 ‘수술간호기록지’에 그 사유를 기록한다.

3. 수술 중 채취한 조직표본 검체 관리

1) 조직표본 검체 채취 후 관리 절차
   (1) 환자에게서 분리된 검체는 소독간호사가 확인 즉시 검체가 마르지 않도록 검체전용용기에 보관한다.
   (2) 순회간호사는 수술간호기록에 채취된 검체의 종류, 부위, 방향, 수량을 정확히 기록한다.
   (3) 환자가 퇴실하기 전 Sign Out을 시행하고, 수술 종료 후 간호사는 환자정보 및 검체 정보가 표시된 검체를 의료진에게 인계한다.
   (4) 검체를 전달하는 간호사(인계하는 간호사)와 검체를 전달받는 의료진(인계받는 의료진)은 수술실검체관리 기록에 각각 서명을 입력한다.
   (5) 검체를 전달받은 의료진(인계받은 의료진)은
      ① 검체 처방을 입력하고 바코드를 출력한다.
      ② 검체는 포르말린병, 검체전용비닐 또는 검체전용용기에 담는다.
      ③ 검체용기에 바코드를 부착하여 라벨링한다.
      ④ 검체 이송직원을 호출한다. (검체 이송직원이 없는 경우, 의사는 바코드가 부착된 검체를 검체보관 냉장고에 보관한다.)
   (6) 검체 이송직원은
      ① 정확한 환자 및 검체의 수량을 확인한다.
      ② 수술실검체관리 기록에 서명을 입력한다.
      ③ 검체를 인계받은 실시간으로 병리과로 검체를 인계한다.
2) 진단검사의학과로 보내는 검체는 수술이 종료되면 즉시 검사 처방 바코드를 부착하여 보낸다.
3) 검체보관 냉장고 관리
   (1) 냉장고 온도: 2-8℃ 유지
   (2) 점검주기: 매일
4) 검체 관리 오류 발생 시 대처
   (1) 담당의사에게 보고하여 처방을 확인한다.
   (2) 검체의 취급과정을 재점검한다.
      ① 인수인계 단계별 검체 부위, 수량, 담당자
      ② 검체보관 냉장고
      ③ 검체이송직원 및 병리과 직원
   (3) 검체 관리 오류가 최종 확인되면 주치의에게 보고한다.
   (4) 환자안전보고서를 작성한다.

제4조 (부록)
1. 수술환자 피부 관리 지침
2. 수술계수(Count) 관리 지침

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)